EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

EMIA35

Exemple fictif

Nora n'existe pas. Son histoire a été entièrement composée pour illustrer ce que contient un bilan d'intervention de l'EMIA35 et la façon dont nous l'écrivons. Elle ne reprend la situation d'aucune personne réelle, et ce document n'a aucune valeur clinique.

Bilan d'intervention

Nora, 21 ans

Accueillie à l'IME, en internat de semaine

Intervention d'avril à septembre 2026

Bilan présenté le 29 septembre 2026

Document confidentiel, établi dans le cadre du secret professionnel partagé. Il ne peut être transmis à un tiers sans l'accord de la personne ou de ses représentants légaux.

Une équipe portée par

Adapei 35 Les papillons blancs

Centre Hospitalier Guillaume Régnier



EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

Identification

La personne

Nora, 21 ans

Accueillie à l'IME depuis ses 14 ans, en internat de semaine

Maintenue au titre de l'amendement Creton

Représentants légaux : ses parents

Le demandeur

L'IME, par sa cheffe de service

En accord avec les parents de Nora

Demande reçue le 12 mars 2026

L'EMIA35

Référent : psychologue

Intervenants : ergothérapeute, coordination éducative, coordination infirmière, psychiatre

Intervention : avril à septembre 2026

Suivi jusqu'en mars 2027

Sommaire

Comment lire ce bilan 3

L'essentiel en une page 4

I. La situation 5

II. Ce que nous avons compris 7

III. Nos préconisations 12

IV. La suite 18

Annexes 20

EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

Comment lire ce bilan

Ce bilan rend compte de l'intervention de l'EMIA35 auprès de Nora, entre avril et septembre 2026. Il s'ancre dans ce que nous avons observé lors de nos temps de présence, dans les évaluations que nous avons conduites et dans ce que Nora, ses proches et les professionnels qui l'accompagnent ont bien voulu nous confier. Comme toute évaluation, la nôtre propose une lecture du fonctionnement de Nora, construite par hypothèses successives, que le quotidien viendra confirmer, nuancer ou contredire. C'est dire que les préconisations qui en découlent sont des pistes à mettre au travail ensemble, et que la période de suivi qui s'ouvre sert précisément à les ajuster.

Nous parlons de « comportements-défis » pour désigner les comportements qui mettent en difficulté la personne ou son entourage : le terme dit le défi qu'ils posent à l'accompagnement, et invite à les lire comme des messages à comprendre.

La page « L'essentiel » résume le bilan pour qui dispose de peu de temps. Les parties suivantes en donnent le détail, et les annexes rassemblent la chronologie complète de l'intervention ainsi que les évaluations dans leur intégralité.

EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

! L'essentiel en une page

Pourquoi nous sommes intervenus

Depuis l'automne 2025, Nora crie, se mord la main et se laisse tomber au sol de plus en plus souvent, surtout lorsqu'elle doit passer d'une activité à une autre et au moment de la toilette du matin. L'IME et ses parents nous ont demandé de les aider à comprendre ce qui se passe pour elle.

Ce que nous avons compris

Nora comprend beaucoup mieux ce qu'elle voit que ce qu'on lui dit, et une chose à la fois. Quand un changement arrive sans qu'elle ait pu le voir venir, surtout quand plusieurs choses changent en même temps, elle perd ses repères : ses comportements lui servent alors à dire « stop ». Certains matins, une douleur, peut-être dentaire ou digestive, pourrait aussi s'exprimer ainsi. L'attente d'une place en foyer ajoute enfin de l'incertitude à son quotidien.

Ce dont Nora a besoin

Voir ce qui va se passer, avec des photos, une étape après l'autre. Que les changements arrivent un par un, et qu'on lui laisse le temps de s'y faire. Que l'on recherche une éventuelle douleur. Des soins adaptés à sa sensibilité. Être préparée, pas à pas, à son futur lieu de vie.

Nos préconisations prioritaires

1. Un emploi du temps en photos, présenté une étape à la fois, le même à l'IME et à la maison.
2. Annoncer chaque transition, et alléger le lundi matin.
3. Un bilan dentaire adapté et un suivi du transit, partagé entre l'IME et la maison.
4. Une toilette, un brossage des dents et des repas adaptés à sa sensibilité.
5. Préparer pas à pas son passage vers le foyer.

EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

I La situation

Nora aujourd'hui

Nora a vingt et un ans. Celles et ceux qui la connaissent parlent d'abord de son rire, qui éclate dans les moments de musique et lorsqu'elle se balance dans le jardin de l'IME, et de sa mémoire étonnante des trajets : en voiture, elle sait avant tout le monde que l'on approche de chez ses grands-parents. Elle aime l'eau sous toutes ses formes, les chansons qu'elle réécoute en boucle sur sa tablette, ranger des objets par couleur, et marcher longtemps, à condition que le chemin soit connu. Elle ne se sépare presque jamais d'un trousseau de grosses clés en plastique coloré, qui l'accompagne depuis l'enfance et qu'elle fait tinter près de son oreille.

Nora parle peu. Elle utilise une dizaine de mots, « encore », « fini », « maman », « dehors », souvent accompagnés d'un geste, et reprend volontiers des fragments de chansons, parfois pour accompagner ce qu'elle fait, parfois, semble-t-il, pour se rassurer. Lorsqu'elle veut quelque chose, elle prend la main de l'adulte et l'y conduit. Elle comprend beaucoup de ce qui se passe autour d'elle, à condition de pouvoir le voir : nous y reviendrons.

Un diagnostic d'autisme a été posé dans sa petite enfance, associé à une déficience intellectuelle. Après plusieurs années en hôpital de jour, Nora est accueillie à l'IME depuis ses quatorze ans, en internat la semaine ; elle rentre chaque week-end chez ses parents, où vit aussi son frère cadet. Depuis ses vingt ans, elle est maintenue à l'IME au titre de l'amendement Creton, qui permet à un jeune adulte de rester dans un établissement pour enfants tant qu'une place adaptée ne s'est pas libérée. La Maison départementale des personnes handicapées l'a orientée vers un foyer d'accueil médicalisé ; elle en a visité un à deux reprises, au début de l'année 2026, et figure sur sa liste d'attente.

Ses parents décrivent une Nora « plus détendue chez nous », où les week-ends se passent le plus souvent sans grande difficulté, tout en reconnaissant que les dimanches soir sont devenus plus agités depuis l'hiver.

La demande

L'IME a sollicité l'EMIA35 le 12 mars 2026, en accord avec les parents de Nora. La fiche de demande décrit, depuis l'automne 2025, une augmentation des moments où Nora est en grande difficulté :

> *« des cris très aigus, qui peuvent durer une vingtaine de minutes » ; « elle se mord le dos de la main, ça laisse des marques » ; « elle se laisse tomber au sol et on ne peut plus la relever » ; « le matin, elle refuse la toilette et nous repousse ».*

L'équipe estimait alors que ces moments survenaient « presque tous les jours, surtout le lundi ».

Au fil des premières rencontres, une autre inquiétude s'est fait entendre, moins formulée mais très présente : celle que ces comportements ne compromettent l'admission de Nora en foyer, alors même que l'attente se prolonge. La demande portait sur les crises ; celle que nous avons entendue porte aussi sur un passage, celui de l'établissement pour enfants à la vie d'adulte, que Nora traverse sans savoir ni quand ni comment il aura lieu.

EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

Notre intervention

1	2	3	4	5	6
Début de l'intervention	Rencontre	Évaluation	Rédaction du bilan	**Présentation du bilan** *nous en sommes là*	Suivi des préconisations

Entre avril et septembre 2026, l'EMIA35 a rencontré Nora à neuf reprises, à l'IME et au domicile familial ; ses parents ont été associés à huit temps de l'intervention. Nous avons observé Nora à des moments choisis avec l'équipe pour ce qu'ils pouvaient nous apprendre : un retour d'internat le lundi matin, un après-midi d'activités, un repas, un samedi à la maison. Nous avons conduit deux évaluations, l'une de sa communication, l'autre de ses particularités sensorielles, et l'équipe de l'IME a consigné pendant quatre semaines les moments difficiles dans des grilles d'observation, ce qui a permis une analyse fonctionnelle. La psychiatre de l'EMIA35 a enfin reçu Nora et ses parents, avec l'infirmière coordinatrice, pour faire le point sur sa santé.

Un premier bilan des évaluations a été présenté à l'équipe et aux parents le 9 juillet 2026 ; le présent bilan en est la version complète. La chronologie détaillée figure en annexe A.

EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

II Ce que nous avons compris

Les évaluations conduites

Évaluation	Ce qu'elle permet de comprendre	Avec qui	Quand
Observations directes	Le fonctionnement de Nora au quotidien, à l'IME et à la maison	Psychologue, ergothérapeute, coordination éducative	mai et juin 2026
ComVoor	Comment Nora perçoit et comprend ce qu'on lui présente : objets, photos, pictogrammes	Coordination éducative, psychologue	16 juin 2026
ESAA	Ses particularités dans le traitement des sensations	Ergothérapeute, avec les parents et l'éducatrice référente	30 juin 2026
Grilles d'observation et analyse fonctionnelle	Ce qui précède et ce qui suit les moments difficiles, pour en comprendre la fonction	Équipe de l'IME ; analyse par le psychologue	1er au 26 juin 2026
Consultation médicale	La santé de Nora et les signes possibles de douleur	Psychiatre, coordination infirmière	7 juillet 2026
Analyse psychologique	Son fonctionnement psychique, à partir de l'ensemble des rencontres	Psychologue	avril à septembre 2026

Nous en présentons ici des extraits choisis ; les résultats complets figurent en annexe B.

Communication et compréhension

Au ComVoor, Nora associe sans hésiter un objet à l'activité qu'il annonce : la serviette pour la piscine, le gobelet pour la collation. Elle reconnaît aussi les photographies des lieux et des personnes qu'elle côtoie, et s'en saisit spontanément pour les montrer. Les pictogrammes dessinés semblent en revanche encore peu porteurs de sens pour elle, à l'exception de deux ou trois qu'elle a appris par l'usage quotidien, comme celui du repas. Surtout, Nora traite un élément à la fois : lorsqu'on lui présente une suite de trois supports, elle s'arrête sur le premier, et les suivants perdent leur fonction d'annonce.

Ce constat éclaire une observation faite à plusieurs reprises. Le planning de son groupe, affiché au mur en pictogrammes et couvrant toute la journée, est un outil précieux pour l'équipe, mais il dit sans doute peu de chose à Nora de ce qui va lui arriver dans les minutes qui viennent. Les consignes orales, quant à elles, semblent comprises lorsqu'elles portent sur une situation présente et familière, « on va manger », beaucoup moins lorsqu'elles annoncent un changement ou un ailleurs, « après la piscine, on ira chercher ton sac ».

> **Ce que nous en retenons.** Nora comprend ce qu'elle voit, une chose à la fois. Pour anticiper, elle a besoin d'objets ou de photos, présentés un par un, au moment où le changement arrive.

Particularités sensorielles

L'ESAA, renseignée avec ses parents et son éducatrice référente puis croisée avec nos observations, dessine un profil contrasté. Sur le plan auditif, Nora paraît très sensible aux bruits soudains ou qui se superposent : au réfectoire, elle se bouche les oreilles et fredonne plus fort dès que le niveau sonore monte, et le sèche-mains des sanitaires de son groupe provoque à lui seul des cris. Autour du visage et de la bouche, le toucher semble également difficile à supporter, qu'il s'agisse du gant de toilette, de la brosse à dents ou d'une main qui s'approche sans prévenir.

À l'inverse, Nora recherche activement certaines sensations : se balancer longtemps, s'appuyer de tout son poids contre un adulte ou contre un mur, serrer très fort ses clés dans la main, se faire envelopper dans une couverture. Ces recherches de pression et de mouvement semblent l'apaiser, et pourraient éclairer en partie le fait qu'elle se morde la main lorsque la tension monte.

> **Ce que nous en retenons.** Les bruits, et le toucher autour du visage, pourraient coûter beaucoup à Nora ; le mouvement et les pressions fortes l'aident à se rassembler. La toilette et les repas sont donc, pour elle, des moments sensoriellement exigeants.

Fonctionnement psychique

Ce qui frappe d'abord, chez Nora, c'est le soin qu'elle met à retrouver le même : le même chemin, les mêmes chansons, les mêmes objets à la même place. Nous y lisons la façon dont elle se construit une continuité dans un monde qui lui arrive par fragments, et qu'elle comprend mal lorsqu'il change sans prévenir. Ses clés en sont le meilleur exemple : elles l'accompagnent d'un lieu à l'autre, de la maison à l'IME et de l'IME à la maison, et le geste de les faire tinter revient précisément aux moments où quelque chose bouge autour d'elle. Le retrait d'un tel objet n'est jamais anodin. Pour des raisons compréhensibles de bruit à table, il a été décidé au printemps de les ranger pendant les repas ; les transmissions de l'équipe situent à peu près au même moment le début des difficultés au réfectoire. Nous ne pouvons pas dire si l'un explique l'autre, mais la coïncidence mérite d'être entendue.

Les transitions sont, pour Nora, le moment où ce fil se rompt. Toutes ne se valent pas : ce qui semble compter, c'est le nombre de choses qui changent en même temps. Passer de la salle d'activité au réfectoire, avec les mêmes adultes et à l'heure habituelle, ne pose guère de difficulté. Le lundi matin, en revanche, Nora change à la fois de lieu, de personnes, de rythme et d'activité, sans avoir pu le voir venir autrement qu'au dernier moment, lorsque la voiture tourne dans l'allée de l'IME. C'est dire que l'écart entre l'avant et l'après s'additionne, et c'est ce cumul, bien plus que le changement en lui-même, qui pourrait la déborder.

Nous avons aussi été attentifs à la façon dont Nora vit la présence des adultes. Elle s'apaise auprès d'un adulte calme, qui reste à proximité sans la solliciter sans cesse ; trop de paroles, trop de mains qui guident, trop d'adultes à la fois semblent la désorganiser autant que l'absence de repère. Le printemps a été marqué, dans son groupe, par plusieurs remplacements successifs liés à des absences : pour Nora, ce sont autant de visages à apprivoiser, et autant de façons différentes d'annoncer les choses.

EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

L'attente d'une place en foyer, enfin, travaille sans doute Nora d'une façon que nous ne pouvons qu'approcher. Elle a visité un foyer à deux reprises, sans que rien ne vienne ensuite lui dire si, quand et comment elle y irait. Ses parents rapportent qu'elle a longuement regardé, à la maison, les photos prises ce jour-là. Il est possible que l'incertitude des adultes autour de son avenir, perceptible dans les conversations, lui parvienne sous une forme qu'elle ne peut pas mettre en mots.

> **i** **Ce que nous en retenons.** Nora se construit une continuité à partir d'objets, de trajets et de rituels. Ce sont les changements multiples et non annoncés qui la mettent en difficulté, davantage que le changement en soi. Elle a besoin d'adultes présents de façon régulée, ni trop ni trop peu, et d'une perspective lisible sur son avenir.

Les comportements-défis et leurs fonctions

Du 1er au 26 juin 2026, l'équipe de l'IME a consigné les moments difficiles dans des grilles d'observation, en notant ce qui s'était passé avant, ce que Nora avait fait, et ce qui avait suivi. Quarante et un moments ont été relevés sur les vingt jours d'accueil de la période. Comme toute donnée recueillie de cette façon, ces grilles dépendent de ce que chacun a repéré, vécu comme difficile et eu le temps d'écrire : elles ne disent pas tout, mais leurs régularités sont parlantes. Plus de la moitié de ces moments surviennent lors d'une transition, et près d'un tiers un lundi, alors que les lundis ne représentent qu'un cinquième des jours d'accueil (détail en annexe B).

Les observations de l'équipe et les nôtres permettent aussi de décrire la façon dont la tension monte chez Nora, et ce qui semble l'aider à chaque étape.

Étape	Ce que l'on peut observer	Ce qui semble l'aider	Ce qui semble l'aggraver
Premiers signaux	Elle fait tinter ses clés plus vite, fredonne plus fort, se lève et se rassoit, porte la main à sa bouche	Moins de paroles ; montrer la photo de ce qui vient ; proposer la balancelle ou un temps à l'écart	Insister, répéter la consigne
Montée	Cris aigus ; elle se mord le dos de la main	Un seul adulte, peu de mots, de l'espace autour d'elle	Lui saisir le bras ; plusieurs adultes autour d'elle
Crise	Elle se laisse tomber au sol et ne peut plus se relever	Sécuriser l'espace, rester proche et calme, attendre	Tenter de la relever, la guider physiquement
Retour au calme	Elle se balance assise, reprend ses clés, fredonne doucement	Lui laisser le temps ; reprendre là où l'on en était, avec la photo	Revenir sur ce qui vient de se passer

Le croisement de ces éléments nous conduit à trois hypothèses, présentées de la plus à la moins étayée.

Arrêter un changement qu'elle n'a pas pu voir venir

C'est l'hypothèse la plus solide : les grilles, nos observations et le récit de l'équipe convergent. Les cris et le fait de se laisser tomber auraient pour fonction de suspendre une situation qui la déborde, et, de fait, ils y parviennent souvent : l'activité est reportée, Nora reste là où elle était. On comprend alors que

ces comportements se maintiennent, puisqu'ils fonctionnent, et que la réponse utile se situe en amont, dans la manière d'annoncer et d'organiser les transitions.

Dire un inconfort physique

Les refus de toilette pourraient tenir pour partie à la sensibilité de son visage et de sa bouche. Mais six des neuf refus de soin relevés se concentrent sur une même semaine, et la consultation médicale a mis en évidence des gencives qui saignent et un transit irrégulier. Il est possible que, certains matins, Nora ait mal, et que ses comportements soient la seule façon dont elle puisse le dire. Cette hypothèse s'appuie sur plusieurs sources convergentes, mais reste à vérifier.

Se rassembler dans l'attente

Lorsqu'il n'y a rien à faire et rien à attendre de visible, Nora semble chercher dans son corps les sensations qui la rassemblent : se balancer, se presser contre un mur, se mordre la main. Cette hypothèse, plus fragile, repose surtout sur l'évaluation sensorielle et sur nos observations ; elle demande à être confirmée pendant le suivi.

> **i** **Ce que nous en retenons. Les comportements de Nora disent le plus souvent « stop, c'est trop », parfois « j'ai mal », parfois « je ne sais pas quoi faire de moi ».** Les prévenir passe par ce qui les précède, bien davantage que par la réponse à la crise.

Santé et douleur

La psychiatre et l'infirmière coordinatrice de l'EMIA35 ont reçu Nora et ses parents le 7 juillet 2026, en présence de l'infirmière de l'IME. Nora ne prend aucun traitement au long cours et ne présente pas de problème de santé connu en dehors de son autisme. Trois éléments ont cependant retenu notre attention. Ses gencives saignent régulièrement au brossage, selon ses parents comme selon l'équipe, et aucun bilan dentaire n'a pu être réalisé depuis quatre ans, les deux dernières tentatives ayant dû être interrompues. Son transit paraît irrégulier, avec des périodes de plusieurs jours sans selles qui ne sont suivies de façon systématique ni à l'IME ni à la maison, faute d'outil commun. Enfin, les signes par lesquels Nora pourrait montrer qu'elle a mal ne sont décrits par personne de la même façon : certains y voient la main portée à la bouche, d'autres le fait de rester couchée le matin.

Chez une personne qui ne peut pas dire qu'elle a mal, toute augmentation soudaine des comportements-défis doit faire penser d'abord à une cause physique : les recommandations de bonnes pratiques le rappellent avec insistance, et la situation de Nora l'illustre bien.

> **i** **Ce que nous en retenons.** Une douleur dentaire ou digestive pourrait participer à certains moments difficiles. Elle est à rechercher activement, avec des outils partagés entre l'IME et la maison.

EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

Synthèse

Ses ressources	Ce qui est difficile	Ses besoins
Une très bonne mémoire des lieux et des trajets	Comprendre ce qui va se passer quand on le lui dit seulement avec des mots	Voir ce qui va se passer, une chose à la fois
Comprend les objets et les photos	Les changements multiples et non annoncés	Un changement à la fois, et du temps pour s'y faire
Sait demander en conduisant l'adulte	Les bruits forts ou soudains	Des adultes présents, calmes, en nombre limité
Des plaisirs nombreux : musique, eau, balancelle, marche	Le toucher autour du visage et de la bouche	Des soins adaptés à sa sensibilité
Un objet qui l'apaise : ses clés	Dire qu'elle a mal	Que l'on recherche une éventuelle douleur
Des parents très présents et une équipe engagée	L'incertitude sur son futur lieu de vie	Être préparée à son futur lieu de vie

En résumé

Nora a besoin de voir venir ce qui va se passer, d'un changement à la fois, et d'adultes qui lisent ses signaux avant qu'ils ne deviennent des cris.

EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

III Nos préconisations

Identifier les besoins de Nora nous permet de formuler des préconisations précises, regroupées par thèmes sous forme de fiches actions. Chaque fiche dit pourquoi elle compte pour Nora, ce que l'on vise et les moyens concrets d'y parvenir, de façon à pouvoir être reprise en équipe, partagée avec la famille ou transmise à un professionnel qui arrive. Ces fiches se complètent et forment, nous l'espérons, un tout cohérent ; le plan d'actions qui ouvre cette partie indique par où commencer.

Le plan d'actions

	Action	Qui la porte	À partir de
1	Un emploi du temps en photos, présenté une étape à la fois, le même à l'IME et à la maison	L'éducatrice référente et les parents, avec l'ergothérapeute et la coordination éducative de l'EMIA35	octobre 2026
2	Annoncer chaque transition, alléger le lundi matin, accompagner les moments de tension	L'équipe du groupe, la cheffe de service de l'IME pour l'organisation	octobre 2026
3	Rechercher une douleur : bilan dentaire adapté, suivi du transit, observation de la douleur	L'infirmière de l'IME, le médecin traitant, les parents	octobre 2026
4	Adapter la toilette, le brossage des dents et les repas à sa sensibilité	L'équipe du groupe et les parents, avec l'ergothérapeute de l'EMIA35	novembre 2026
5	Préparer pas à pas le passage vers le foyer	La direction de l'IME, les parents et le foyer, avec l'EMIA35	dès maintenant pour l'album photo

EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

Les fiches actions

FICHE ACTION 1

Voir ce qui va se passer

Pourquoi c'est essentiel pour Nora

Nora comprend ce qu'elle voit bien mieux que ce qu'on lui dit, et une chose à la fois. Le planning mural de son groupe, en pictogrammes et sur la journée entière, lui parle peu. Lui donner un outil à sa mesure, c'est lui permettre d'anticiper, et donc de moins subir les changements.

OBJECTIFS	MOYENS CONCRETS
Rendre visible ce qui vient	• Un emploi du temps vertical en photos des lieux et des activités réels, fixé à hauteur de ses yeux. • Deux photos seulement à la fois, sur le modèle « maintenant, puis après » : l'activité en cours en haut, la suivante juste en dessous. • Quand une activité se termine, Nora retire elle-même la photo et la glisse dans une enveloppe « fini ».
Relier l'IME et la maison	• Les mêmes photos, au même format, dans les deux lieux, pour les moments qui s'y répètent : repas, toilette, voiture, coucher. • Un petit carnet de photos qui fait le trajet avec elle, pour annoncer à la maison le retour à l'IME, et à l'IME le retour à la maison.
Avancer pas à pas	• Commencer par les deux ou trois moments de la journée qui posent le plus de difficulté, avant d'étendre. • Le planning en pictogrammes peut rester au mur pour le groupe ; pour Nora, ce sont les photos qui font foi.
Qui ? Quand ?	L'éducatrice référente et les parents, avec l'ergothérapeute et la coordination éducative de l'EMIA35 pour la fabrication des supports. Dès octobre 2026, premier point en novembre.

Repère : HAS et ANESM, Trouble du spectre de l'autisme : interventions et parcours de vie de l'adulte, recommandation de bonnes pratiques, décembre 2017.

EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

FICHE ACTION 2

Traverser les transitions et les moments de tension

Pourquoi c'est essentiel pour Nora

Plus de la moitié des moments difficiles relevés surviennent lors d'une transition, et près d'un tiers un lundi. C'est le cumul des changements, plus que le changement lui-même, qui semble déborder Nora : on peut agir sur ce cumul, et lire ses premiers signaux pour intervenir avant la crise.

OBJECTIFS	MOYENS CONCRETS
Annoncer chaque transition	• Montrer la photo ou l'objet de l'activité suivante, puis laisser à Nora quelques instants avant de bouger. • Un même mot et un même geste pour dire « fini », utilisés par tous. • Éviter de changer plusieurs choses à la fois : si le lieu change, garder autant que possible le même adulte, et inversement.
Alléger le lundi matin	• Un accueil assuré, autant que possible, par un adulte qu'elle connaît bien, dans un lieu calme, avec une activité qu'elle aime. • Le dimanche soir, à la maison, regarder avec elle la photo de cet accueil et de l'adulte qui l'attendra. • Garder les activités nouvelles ou inhabituelles pour un autre jour.
Lire les premiers signaux	• Clés qu'elle fait tinter plus vite, fredonnement qui s'accélère, main portée à la bouche : c'est le moment de réduire la parole et de proposer la balancelle ou un temps à l'écart. • À ce stade, renoncer à la consigne plutôt que la répéter.
Pendant la crise	• Sécuriser l'espace et éloigner les autres jeunes, plutôt que Nora. • Un seul adulte, à proximité, peu de mots, sans la saisir. • Si elle se mord la main : réduire toute sollicitation, lui laisser de l'espace, lui proposer l'objet de mastication introduit en dehors des crises (fiche 4). • Attendre qu'elle se relève d'elle-même.
Après	• Reprendre là où l'on en était, avec la photo, sans revenir sur ce qui s'est passé. • Noter le moment dans la grille d'observation, en précisant ce qui l'a précédé.
Ses clés	• Les laisser à Nora en toutes circonstances, repas compris. Si le bruit gêne à table, une pochette en tissu peut les assourdir sans les lui retirer.

Qui ? Quand ?	Toute l'équipe du groupe et les parents ; la cheffe de service de l'IME pour l'organisation du lundi matin et la stabilité des adultes autour de Nora. Dès octobre 2026.

Repère : ANESM, Les « comportements-problèmes » au sein des établissements et services accueillant des enfants et adultes handicapés : prévention et réponses, recommandation de bonnes pratiques, décembre 2016.

FICHE ACTION 3

Rechercher une douleur et suivre la santé

Pourquoi c'est essentiel pour Nora

Nora ne peut pas dire qu'elle a mal. Ses gencives saignent, son transit est irrégulier, et ses refus de soin se sont concentrés sur une même semaine : une douleur pourrait se cacher derrière une partie de ses comportements. La rechercher fait pleinement partie de l'accompagnement.

OBJECTIFS	MOYENS CONCRETS
Faire un bilan dentaire	• Solliciter une consultation dentaire adaptée aux personnes en situation de handicap, qui dispose du temps et, si besoin, des moyens de sédation nécessaires. • La préparer avec Nora : photos du lieu et du trajet, une première visite sans soin si c'est possible. • Le médecin traitant peut appuyer la demande.
Suivre le transit	• Une grille simple de suivi des selles, la même à l'IME et à la maison, glissée dans le carnet de Nora. • Au-delà de trois jours sans selles, en informer l'infirmière de l'IME ou le médecin traitant.
Repérer la douleur	• Les matins difficiles, utiliser une grille d'observation de la douleur adaptée aux personnes qui communiquent peu ; le choix de l'outil revient à l'équipe soignante. • Construire avec les parents la liste des signes par lesquels Nora pourrait montrer qu'elle a mal, et la partager avec tous. • Toute augmentation soudaine des comportements-défis doit faire penser d'abord à une cause physique.
Qui ? Quand ?	L'infirmière de l'IME, en lien avec le médecin traitant et les parents. La coordination infirmière de l'EMIA35 reste disponible pendant le suivi. Demande de consultation dentaire en octobre 2026 ; grilles en place dès octobre.

EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

FICHE ACTION 4

Adapter les soins et les repas à sa sensibilité

Pourquoi c'est essentiel pour Nora

Le toucher autour du visage et de la bouche, comme les bruits forts, semblent coûter beaucoup à Nora. La toilette, le brossage des dents et les repas sont donc pour elle des moments exigeants, et ils concentrent une part importante de ses difficultés.

OBJECTIFS	MOYENS CONCRETS
Le brossage des dents	• Une brosse à poils très souples et un dentifrice au goût neutre, non mentholé. • Une séquence en trois photos, toujours la même. • Compter à voix haute, ou chanter un court passage d'une chanson qu'elle aime, pour qu'elle sache quand cela finit. • Lui proposer de tenir la brosse, l'adulte guidant sa main si elle l'accepte.
La toilette	• Prévenir avant de toucher, en montrant le gant. • Des pressions fermes plutôt que des frottements légers, souvent plus difficiles à supporter. • Une serviette plutôt que le sèche-cheveux ; éviter le sèche-mains.
Les repas	• Une place en bout de table, dos au mur, à l'écart des passages. • Un casque antibruit à disposition, que Nora peut prendre et retirer elle-même. • Ses clés restent avec elle (fiche 2).
Répondre à ses besoins de pression et de mouvement	• Des temps de balancelle ou de mouvement inscrits dans sa journée, avant les moments exigeants plutôt qu'après. • Un objet de mastication, introduit d'abord dans des moments calmes, comme alternative à la morsure de la main. • Une couverture lestée, à essayer avec l'ergothérapeute, sur des temps courts et sous surveillance.
Qui ? Quand ?	L'équipe du groupe et les parents, avec l'ergothérapeute de l'EMIA35 pour le choix et l'essai du matériel. Novembre 2026.

FICHE ACTION 5 · À TESTER ET AJUSTER

Préparer le passage vers le foyer

Pourquoi c'est essentiel pour Nora

Nora attend une place en foyer sans pouvoir se représenter ni le lieu, ni le moment, ni la façon dont elle y arrivera. Ce passage, le plus important des années à venir, cumule tous les changements à la fois : il ne peut se préparer que pas à pas, en s'appuyant sur ce qui l'aide déjà. Les propositions ci-dessous seront essayées puis ajustées au fil du suivi.

CE QUE NOUS PROPOSONS	CE QUE NOUS AVONS OBSERVÉ	CE QUE NOUS AJUSTONS
Un album photo du foyer : les lieux, sa future chambre, les visages, le trajet, à regarder avec elle à la maison et à l'IME.		
Des visites courtes et répétées, toujours le même jour et à la même heure, accompagnée d'un adulte qu'elle connaît.		
Retrouver au foyer ce qui l'aide déjà : ses clés, ses chansons, une activité de mouvement.		
Une conduite d'accompagnement d'une page, rédigée avec les parents et l'équipe, pour les professionnels qui l'accueilleront.		
Transmettre ce bilan au foyer au moment de l'admission, avec l'accord des parents.		

Qui ? Quand ? La direction de l'IME, les parents et le foyer, avec l'appui de l'EMIA35 pendant le suivi. L'album photo peut commencer dès maintenant ; le reste, dès que l'admission sera envisagée.

EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

IV La suite

La présentation de ce bilan marque la fin de la phase d'évaluation et ouvre la phase de suivi des préconisations, d'une durée de six mois. Pendant cette période, nous restons disponibles pour ajuster les préconisations avec vous, à partir de ce que leur mise en place fait apparaître : certaines tiendront telles quelles, d'autres demanderont à être affinées par essais successifs, et c'est ce travail d'ajustement qui leur donne leur valeur.

Les rendez-vous prévus sont indiqués ci-dessous ; d'autres peuvent être organisés à votre demande. Au terme de ces six mois, un courrier de fin d'intervention vous sera adressé, accompagné d'un questionnaire de satisfaction qui nous aide à faire évoluer notre pratique.

Ce bilan vient en appui de celles et ceux qui accompagnent Nora au quotidien ; les décisions de soin et d'orientation restent du ressort des instances et des professionnels qui en ont la charge.

Les rendez-vous du suivi

Quand	Pour quoi faire	Avec qui
17 novembre 2026	Premier point sur l'emploi du temps en photos et sur le lundi matin	L'équipe du groupe, les parents ; l'ergothérapeute et la coordination éducative de l'EMIA35
19 janvier 2027	Point d'étape sur l'ensemble des fiches, dont le bilan dentaire	L'équipe, l'infirmière de l'IME, les parents ; le psychologue et la coordination infirmière de l'EMIA35
23 mars 2027	Bilan du suivi et fin de l'intervention	La direction et l'équipe de l'IME, les parents ; l'équipe de l'EMIA35

EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

Signatures

Fonction	Nom	Signature
Nora		
Ses parents, représentants légaux		
Direction de l'IME		
Psychologue référent, EMIA35		
Ergothérapeute, EMIA35		
Coordination éducative, EMIA35		
Coordination infirmière, EMIA35		
Psychiatre, EMIA35		

EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

A Annexes

A. Chronologie de l'intervention

Date	Ce qui a eu lieu	EMIA35	Autres participants
12/03/2026	Réception de la demande	Chef de service	Direction de l'IME
26/03/2026	Étude de la demande en réunion d'équipe	Équipe EMIA35	
09/04/2026	Signature de la convention, à l'IME	Psychologue, coordination éducative	Nora, ses parents, la direction et l'éducatrice référente de l'IME
23/04/2026	Rencontre au domicile familial	Psychologue, coordination éducative	Nora, ses parents
18/05/2026	Observation d'un retour d'internat, le lundi matin	Psychologue, coordination éducative	Nora, ses parents, l'équipe du groupe
28/05/2026	Observation d'un après-midi d'activités	Ergothérapeute, psychologue	Nora, l'équipe du groupe
01/06 au 26/06/2026	Recueil des grilles d'observation	Psychologue (analyse)	L'équipe du groupe
06/06/2026	Observation au domicile, un samedi	Coordination éducative	Nora, ses parents, son frère
11/06/2026	Observation d'un repas	Ergothérapeute	Nora, l'équipe du groupe
16/06/2026	Évaluation de la communication (ComVoor)	Coordination éducative, psychologue	Nora, l'éducatrice référente
30/06/2026	Évaluation sensorielle (ESAA), en entretien	Ergothérapeute	Les parents, l'éducatrice référente
07/07/2026	Consultation médicale	Psychiatre, coordination infirmière	Nora, ses parents, l'infirmière de l'IME
09/07/2026	Présentation du bilan synthétique des évaluations	Psychologue, ergothérapeute, coordination éducative	Les parents, la direction et l'équipe de l'IME
29/09/2026	Présentation du bilan d'intervention	Équipe EMIA35	Nora, ses parents, la direction et l'équipe de l'IME

EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

B. Les évaluations : compléments

Grilles d'observation, du 1er au 26 juin 2026

Moment où survient la difficulté	Nombre	Part
Transition : changement de lieu, d'activité ou d'adulte	22	54 %
Toilette et soins du matin	9	22 %
Attente sans activité	7	17 %
Autre ou non précisé	3	7 %
Total	**41**	**100 %**

Sur ces quarante et un moments, treize ont eu lieu un lundi, soit près d'un tiers, alors que les quatre lundis ne représentent qu'un cinquième des vingt jours d'accueil : on compte en moyenne un peu plus de trois moments difficiles le lundi, contre un peu moins de deux les autres jours. Six des neuf refus de soin du matin se situent dans la semaine du 8 juin.

Communication : ComVoor, le 16 juin 2026

Support	Nora le perçoit et le reconnaît	Nora comprend ce qu'il annonce
Objets	Oui	Oui, pour les activités familières
Photographies	Oui	Oui, pour les lieux et les personnes qu'elle connaît
Pictogrammes	Oui	Partiellement : deux ou trois, appris par l'usage
Mots écrits	Non	Non

Présentés en séquence, les supports ne sont traités qu'un par un : au-delà de deux, les suivants ne jouent plus leur rôle d'annonce.

Particularités sensorielles : ESAA, le 30 juin 2026

Sens	Ce que nous avons observé ou recueilli	Tendance
Audition	Se bouche les oreilles au réfectoire ; cris au déclenchement du sèche-mains	Très sensible
Toucher	Difficultés avec le gant de toilette, la brosse à dents, une main qui approche du visage ; apprécie d'être enveloppée	Sensible autour du visage, recherche de pressions fortes
Mouvement et équilibre	Se balance longuement, apprécie la balancelle et la marche	Recherche

EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

Sens	Ce que nous avons observé ou recueilli	Tendance
Sensations du corps	S'appuie de tout son poids, serre fort ses clés, se mord la main quand la tension monte	Recherche
Vue	Attirée par les reflets de l'eau ; repère vite un objet déplacé	Peu de particularité gênante
Goût et odorat	Repas sans difficulté particulière en dehors du bruit	Peu de particularité gênante

C. Ton bilan, facile à lire

Nora, nous sommes l'EMIA35.

Nous sommes venus te voir à l'IME et à la maison, au printemps et en été.

Nous avons regardé ce que tu aimes et ce qui est difficile pour toi.

Tu aimes la musique, l'eau, la balancelle, marcher et tes clés.

Quand les choses changent trop vite, c'est difficile pour toi. Tu peux crier, te mordre la main ou tomber par terre.

Parfois, tu as peut-être mal aux dents ou au ventre. C'est difficile à dire.

Maintenant :

Tu vas avoir des photos pour voir ce qui va se passer, à l'IME et à la maison.

On va te montrer chaque changement avant qu'il arrive.

Tu vas aller chez le dentiste. On te montrera des photos avant.

Tu gardes tes clés avec toi, tout le temps.

Tu vas visiter ton futur foyer plusieurs fois, avec une personne que tu connais.

Nous revenons te voir en novembre, en janvier et en mars.

D. Les principes qui guident notre accompagnement

Le tableau ci-dessous explicite les principes qui guident nos préconisations. Il met en regard notre vision de l'accompagnement, ce qu'elle implique concrètement au quotidien, et les écueils qu'elle cherche à éviter.

EXEMPLE FICTIF, SANS VALEUR CLINIQUE · Nora n'existe pas. Ce bilan a été écrit pour montrer à quoi ressemble un bilan d'intervention de l'EMIA35.

Notre vision	Concrètement	Points de vigilance
Lire le comportement comme un message	Considérer chaque comportement comme l'expression d'un besoin ou d'une difficulté	Interpréter trop vite, ou juger le comportement
Structurer	Donner des repères stables ; organiser les temps, les espaces et les façons d'accompagner pour rendre le quotidien lisible et sécurisant	Rigidifier le cadre ; appliquer des protocoles figés sans les adapter
Ritualiser	Installer des repères réguliers et prévisibles qui aident à comprendre et à anticiper	Imposer des rituels que la personne ne comprend pas ou n'a pas choisis
Une posture stable, fiable et contenante	Être un adulte calme et prévisible, dans le ton, la présence et les réponses	Froideur relationnelle, distance affective, désengagement
Une communication claire et épurée	Des consignes simples, courtes, explicites, adaptées au niveau de compréhension	Surcharge verbale ; consignes multiples ou implicites
Soutenir la compréhension	Utiliser des supports, des démonstrations, des repères visuels	Sur-expliquer jusqu'à inquiéter ; discours abstrait
Une présence régulée	Être disponible quand la personne en a besoin, tout en soutenant son autonomie : ni trop, ni trop peu	Sur-solliciter ; envahir la relation
Respecter les particularités sensorielles et cognitives	Adapter l'environnement, le rythme et les sollicitations	Ignorer la fatigabilité, le temps de latence, les besoins sensoriels
Sécuriser par l'environnement	Aménager des espaces lisibles et apaisants, limiter les stimulations parasites	Environnement surstimulant ou désorganisé
La cohérence entre les lieux et les personnes	Harmoniser les pratiques pour offrir un cadre stable et compréhensible	Des réponses qui dépendent de la personne présente plutôt que du cadre

E. Comprendre les particularités sensorielles

Nos sens sont nos premiers moyens de découverte du monde. Ce que nous voyons, entendons, touchons, goûtons et sentons, mais aussi la perception de notre corps dans l'espace, de l'équilibre et des sensations internes, forme le socle sur lequel se construisent ensuite les apprentissages moteurs, la compréhension de l'environnement et la relation aux autres.

L'intégration sensorielle désigne la capacité du cerveau à recevoir ces informations, à les traiter et à y répondre de façon ajustée. Chez de nombreuses personnes autistes, ce traitement fonctionne autrement : une sensation peut être perçue avec une intensité telle qu'elle devient envahissante, voire douloureuse, ou au contraire si peu qu'elle pousse la personne à la rechercher activement. Un même bruit, un même contact, n'ont donc pas le même effet d'une personne à l'autre, ni parfois d'un jour à l'autre chez la même personne, selon sa fatigue ou son niveau de tension.

Comprendre ces particularités permet d'ajuster la posture, l'aménagement des lieux, le choix des activités et les moyens d'apaisement. C'est aussi ce qui permet de lire autrement certains comportements, qui peuvent être une façon de se protéger d'une sensation trop forte ou d'aller chercher celle qui manque.